EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 66737
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-06-30 13:12:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: PEDRO ANTONIO SANDOVAL VELASQUEZ			RUN	: 9.592.566-9
F.Nac	: 29-06-1962	Edad	: 61 AÑOS	Género	: Masculino
Dirección	: EL QUILMEN RANCHILLO			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 79515743		
Fecha Ingreso	: 17-05-2023	Fecha Egreso	: 2023-06-30 13:12:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J94.2-HEMOTORAX

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

HEMOTÓRAX no TRAUMÁTICO ORGANIZADO IZQUIERDO
IAM Antiguo 2020
CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCARDICA 2021
HTA
HIPOTIROIDISMO
GOTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J94.2-HEMOTORAX (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I48.1-FIBRILACION AURICULAR PERSISTENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I25.2-INFARTO ANTIGUO DEL MIOCARDIO. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I24.0-TROMBOSIS CORONARIA QUE NO RESULTA EN INFARTO DEL MIOCARDIO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. E03-OTRO HIPOTIROIDISMO. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. M10-GOTA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente hospitalizado el 17-05-2023 por cuadro de dolor hemitórax izquierdo con tope inspiratorio y debido a sus antecedentes se estudia con , además, TAC de Tórax; que evidencia ocupación del hemitórax izquierdo hasta el nivel del 6° EIC y sin evidencia de Fracturas costales. Tratado con Toracotomía Mínima que no pudo resolver el hemotórax organizado, por lo que se solicitó evaluación y tratamiento por Cirugía de Tórax de HGGB, que fue aceptado y a la espera de cama asignada por Gestión de Camas.
Se decide continuar tratamiento sintomático en Hospitalización domiciliaria por necesidad de anticoagulación por AC x FA en TACO y, que al ser trasladodo a Cirugía Torácica, se requiere suspensión rápida de TACO y estar en condiciones de ser llevado a Quirófano sin estar bajo efectos de Acenocumarol; se ha decidido anticoagular con HBPM que a dosis ajustada a su peso, le corresponde a 80 mg c/12h sc.

PLAN DE MANEJO:

Tratamiento Quirúrgico en HGGB
Controles en CAE Cirugía HSC con Dra. Díaz.

INDICACIONES AL ALTA

1. Caminar 30 min TID
2. Dieta hiposódica, sin grasas

3. Tratamiento de Enfermedades Crónicas por su CESFAM
4. Ejercicios con Triflow
5. KNT-R
6. Enoxaparina 80 mg sc c/12h
7. Paracetamol 500 mg vo c/8h
8. Metamizol 1 tab vo c/8h
9. Control en CAE Cirugía con Dra. Díaz en 15 días.
10. A la espera de Cama en Cirugía Tórax de HGGB.

EXÁMENES Y RESULTADOS

TAC Tórax
Ex. Sangre.

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

ERIC VALDIVIESO LOPEZ
MEDICO TRATANTE
14718240-6

JEFE SERVICIO